RECOMENDACIONES TRAZADORAS GPC:
Síndrome Coronario Agudo

A continuación se presentan de manera resumida las recomendaciones trazadoras adaptadas de la Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario agudo en adultos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2014) y de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo del síndrome coronario agudo (ESC, 2023), ajustadas al contexto y a los procesos asistenciales de nuestra institución, con el fin de orientar una atención oportuna, estandarizada y basada en la evidencia.

Recomendación 1: Realizar evaluación clínica inmediata y estructurada en todo paciente con síntomas sugestivos de síndrome coronario agudo.

¿Quién? – Responsable: Médico general o Medicina de Urgencias

¿Cómo? – Acciones: Registrar en la historia clínica:

1. Características del dolor torácico
   - Dolor opresivo retroesternal
   - Irradiación a brazo izquierdo, mandíbula, cuello o espalda
   - Duración mayor a 20 minutos
   - Asociación con disnea, diaforesis, náuseas o síncope
2. Identificación de equivalentes anginosos
   - Disnea súbita
   - Fatiga inexplicada
   - Dolor epigástrico
   - Mareo o síncope
3. Factores de riesgo cardiovascular
   - Hipertensión arterial
   - Diabetes mellitus
   - Dislipidemia
   - Tabaquismo
   - Enfermedad cardiovascular previa
4. Exploración física cardiovascular
   - Evaluación hemodinámica
   - Signos de insuficiencia cardiaca
   - Arritmias
   - Soplos nuevos
5. Electrocardiograma de 12 derivaciones
   - Debe realizarse dentro de los primeros 10 minutos del primer contacto médico.

Recomendación 2: Se recomienda la medición de troponina cardiaca como biomarcador de elección en el diagnóstico del síndrome coronario agudo.

¿Quién? – Responsable: Médico general o Medicina de Urgencias

¿Cómo? – Acciones:

- Dado que la institución no cuenta con determinación de troponina cardíaca de alta sensibilidad, la evaluación de troponina se realizará con el esquema seriado 0–3–6 horas. En pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo que consulten de forma temprana tras el inicio de los síntomas, se deberá realizar una determinación inicial al ingreso, repetir a las 3 horas y, si el resultado es negativo y persiste la sospecha clínica, realizar una tercera medición a las 6 horas.

  La negatividad seriada en este esquema, junto con la valoración clínica y electrocardiográfica, permite descartar síndrome coronario agudo.

- En la institución se considera como punto de corte para confirmación diagnóstica de infarto agudo de miocardio un valor de troponina ≥ 0,5 ng/mL. Valores superiores a este umbral, en el contexto clínico compatible, confirman el diagnóstico de IAM. Cuando la troponina se encuentra elevada pero por debajo del punto de corte diagnóstico (> 0,04 ng/mL y < 0,5 ng/mL), se deben considerar posibles causas de elevación miocárdica distintas al síndrome coronario agudo y realizar una nueva medición seriada de troponina para evaluar cambios dinámicos.

- Clasificar al paciente de acuerdo al resultado de la troponina en:

  - Diagnóstico descartado
  - Diagnóstico confirmado
  - Zona de observación: Realizar medición seriada de troponina.

- Interpretar nuevamente resultados de troponina considerando:

  - Síntomas clínicos
  - Cambios electrocardiográficos
  - Variación dinámica de troponina

Recomendación 3: Realizar estratificación del riesgo en síndrome coronario agudo sin elevación del ST

¿Quién? – Responsable: Médico general/ Medicina interna / Medicina de urgencias / Cuidado intensivo

¿Cómo? – Acciones: Realizar clasificación del riesgo con escalas validades como GRACE ó TIMI.

Clasificación por GRACE:

- Muy alto riesgo: Requiere coronariografía inmediata (<2 horas).

  Criterios:

  - Inestabilidad hemodinámica
  - Shock cardiogénico
  - Dolor torácico persistente refractario
  - Arritmias ventriculares malignas
  - Insuficiencia cardiaca aguda

- Alto riesgo: Requiere estrategia invasiva temprana (<24 horas).

  Criterios:

  - Troponina elevada
  - Cambios dinámicos del ST
  - Score GRACE Elevado

- Riesgo intermedio: Requiere estrategia invasiva dentro de las primeras 72 horas de hospitalización.

Recomendación 4: Se recomienda reperfusión miocárdica urgente en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

¿Quién? – Responsable: Urgencias / Cardiología / Hemodinamia.

¿Cómo? – Acciones:

- Realizar: Intervención coronaria percutánea primaria (ICP primaria) como estrategia de elección.
  - Objetivo de tiempo:

    - Primer contacto médico → reperfusión ≤120 minutos.

- Si la intervención coronaria no puede realizarse dentro de ese tiempo: Administrar **fibrinólisis temprana**. Posteriormente realizar estrategia fármaco invasiva con coronariografía entre 2 y 24 horas después de la fibrinolisis.

Recomendación 5: Se recomienda iniciar tratamiento antitrombótico inmediato en pacientes con síndrome coronario agudo (SCACEST – SCASEST), salvo contraindicación.

¿Quién? – Responsable: Médico de urgencias / Cardiología / Medicina interna.

¿Cómo? – Acciones:

- Indicar **oxígeno** si saturación < 90%, disnea o signos de hipoxemia.
- Indicar **nitratos** así:

  - Nitroglicerina sublingual 0,4 mg cada 5 minutos (hasta 3 dosis) si persiste dolor.
  - Si el dolor continúa o hay hipertensión/isquemia persistente: nitroglicerina IV.
  - EVITAR nitratos en: hipotensión (PAS <90 mmHg), infarto de ventrículo derecho, uso reciente de inhibidores de fosfodiesterasa (sildenafil)

- Indicar **morfina IV** si el dolor torácico persiste pese nitratos.
- Indicar **antiagregación plaquetaria** así:

  - Aspirina: 150–300 mg VO carga, luego 75–100 mg/día.
  - Clopidogrel: <75 años: carga 300 mg; ≥75 años: 75 mg sin carga. Mantenimiento: 75 mg/día. Si paciente va a ICP carga 600 mg.

- Indicar **anticoagulación** así:

  - Enoxaparina:
    - <75 años: bolo IV 30 mg. Luego 1 mg/kg SC cada 12 h
    - ≥75 años: Sin bolo inicial. Luego 0.75 mg/kg SC cada 12 h
    - Si TFG < 30: Sin bolo inicial. Luego 1 mg/kg SC cada 24 h

  - Alternativa: heparina no fraccionada en infusión. Bolo 60 UI/kg (máximo 4000 UI), luego infusión 12 UI/kg/h (máximo 1000 UI/h).

Recomendación 6: Se recomienda fibrinólisis en SCACEST cuando no es posible realizar angioplastia coronaria primaria dentro de los 120 minutos desde el primer contacto médico y el inicio de los síntomas es menor a 12 horas.

¿Quién? – Responsable: Médico de urgencias / Medicina interna / UCI

¿Cómo? – Acciones:

- Indicar fibrinolítico (uno de los siguientes)

  - Tenecteplasa (TNK): bolo IV único según peso (30–50 mg). En pacientes ≥75 años se recomienda reducir la dosis al 50 % para disminuir riesgo de hemorragia intracraneal.

  - Alteplasa: esquema acelerado IV según peso
    - 15 mg IV bolo
    - 0.75 mg/kg en 30 minutos (máximo 50 mg)
    - 0.5 mg/kg en 60 minutos (máximo 35 mg)

- Indicar antiagregación así:

  - Aspirina: 150–300 mg VO carga, luego 75–100 mg/día.
  - Clopidogrel:
    - <75 años: carga 300 mg. Mantenimiento: 75 mg/día.
    - ≥75 años: 75 mg sin carga. Mantenimiento: 75 mg/día.

- Indicar Anticoagulación así:

  - Enoxaparina:
    - <75 años: bolo IV 30 mg. Luego 1 mg/kg SC cada 12 h
    - ≥75 años: Sin bolo inicial. Luego 0.75 mg/kg SC cada 12 h
    - Si TFG < 30: Sin bolo inicial. Luego 1 mg/kg SC cada 24 h

  - Alternativa: heparina no fraccionada en infusión. Bolo 60 UI/kg (máximo 4000 UI), luego infusión 12 UI/kg/h (máximo 1000 UI/h).

- Evaluar contraindicaciones principales en fibrinólisis:

  - Contraindicaciones absolutas
    - Hemorragia intracraneal previa
    - ACV isquémico en los últimos 6 meses
    - Tumor intracraneal o malformación vascular cerebral
    - Disección aórtica sospechada

- Sangrado activo o diátesis hemorrágica
- Trauma cráneo encefálico grave reciente
- Cirugía mayor reciente con riesgo de sangrado

o Contraindicaciones relativas
- HTA severa no controlada (>180/110 mmHg)
- ACV isquémico previo >6 meses
- Uso de anticoagulación oral
- Embarazo o posparto
- RCP traumática o prolongada
- Enfermedad hepática avanzada

- Realizar evaluación de reperfusión así:

o Se debe evaluar a los 60–90 minutos posteriores al fibrinolítico.
o Se considera fibrinólisis exitosa cuando existe resolución ≥50 % del segmento ST, mejoría del dolor torácico o presencia de arritmias de reperfusión.

- Indicar conductas adicionales post-fibrinólisis:

o Fibrinólisis exitosa: remitir para angiografía coronaria entre 2–24 horas (estrategia fármaco invasiva).

o Fibrinólisis fallida: Indicar angioplastia de rescate urgente.
o El paciente debe permanecer en monitorización continua, con vigilancia de sangrado, estado neurológico, cambios electrocardiográficos y recurrencia de síntomas en Unidad de Cuidado Intensivo.